

ΟΞΕΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ - ΜΕΘΗ

Γενικά: Η Αιθανόλη αποτελεί μια νόμιμη εξαρτησιογόνο ψυχοτρόπο ουσία, αλλά και μια συστηματική τοξίνη και κατασταλτικό του ΚΝΣ. Παρότι η σοβαρή τοξικότητα από την κατάχρηση αιθανόλης μπορεί να προκαλέσει άμεσα τον θάνατο (σε επίπεδα > 500 mg/dl) λόγω αναπνευστικής καταστολής, η νοσηρότητα και η θνητότητα οφείλονται συνήθως σε τυχαίο, ακούσιο (σπανίως εκούσιο) τραυματισμό, εξαιτίας της μειώσεως των γνωσιακών λειτουργιών και της στρεβλής και διαταραγμένης αντίληψης του περιβάλλοντος.

Ως δηλητηρίαση από την Αιθανόλη ορίζεται η συγκέντρωση στο αίμα 100-150 mg/dl. Σε συγκεντρώσεις 150-250 mg/dl παρατηρείται δυσαρθρία, απώλεια του κινητικού ελέγχου με αταξία και αστάθεια βάδισης, διπλωπία, άρση των αναστολών, ενώ σε συγκεντρώσεις αλκοόλης στο αίμα επιπέδου 250-400 mg/dl εμφανίζονται διαταραχή των ζωτικών σημείων, ακανόνιστη αναπνοή, ροχαλητό, ακράτεια ούρων, ληθαργική κατάσταση, κόμα.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής μπορεί να προσέλθει στο ΤΕΠ σε κατάσταση ήπιας μέθης ή ακόμη και σε κωματώδη κατάσταση λόγω της καταστολής του ΚΝΣ. Μπορεί να εμφανίζει δυσαρθρία ή κολλώδη ομιλία, άρση αναστολών, διέγερση, σύγχυση, νυσταγμό, αταξία κ.ά. Μπορεί, ενίοτε, να παρουσιαστεί οξεία μυοπάθεια και ραβδομυόλυση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, σύνδρομο Mallory Weiss, οξεία παγκρεατίτιδα ή σπανιότερα εικόνα οξείας κοιλίας. Το οινόπνευμα μειώνει, επίσης, τον συδό εμφάνισης κοιλιακής μαρμαρυγής (ΚΜ). Έχει βρεθεί ότι ακόμη και ένα μεμονωμένο επεισόδιο βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης καρδιακών αρρυθμιών (**Holiday Heart Syndrome**). Μπορεί, επίσης, εκτός της ΚΜ, να εμφανιστεί οξύ πνευμονικό οίδημα ή βαριά υπόταση (*shock*).

Συννοσηρότητες: Πολλές φορές η κατάχρηση Αιθανόλης σχετίζεται με ταυτόχρονη χρήση άλλων παράνομων ουσιών, γεγονός που πρέπει να λαμβάνουμε υπ' όψιν κατά τη διαφορική διάγνωση και τη θεραπεία της μέθης. Η επαγωγή του μεταβολισμού στους χρόνιους χρήστες αλκοόλης μπορεί εν μέρει να εξηγήσει την αντοχή τους στα κατασταλτικά του ΚΝΣ που παρατηρείται σε αυτούς. Αυξημένη όμως κεντρική κατασταλτική δράση μπορεί να συμβεί με ένα κατασταλτικό του ΚΝΣ που λαμβάνεται σε συνδυασμό με αλκοόλη.

Οι διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων των οποίων αυξάνεται η κεντρική κατασταλτική δράση μετά από τη συγχρόνηση αλκοόλης, περιλαμβάνουν: αντισταμινικά, οπιοειδή, βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωσικά και αντικαταθλιπτικά.

Προσοχή απαιτείται κατά την αντιμετώπιση ασθενούς σε μέθη με συνοδό τραυματισμό, ιδίως ΚΕΚ, οπότε η κλινική εικόνα μπορεί να είναι συγκεχυμένη. Η παθολογική χρήση του οινοπνεύματος έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αρχική αντιμετώπιση ασθενών με τραύμα, με ποικίλους τρόπους. Ο τραυματίας σε κατάσταση μέθης εμφανίζει διπλάσιες πιθανότητες διασωλήνωσης προκειμένου να διαφυλαχτεί η βατότητα της αναπνευστικής οδού.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η μέθη αποτελεί **συστηματική δηλητηρίαση** και για αυτό προτεραιότητα στη θεραπεία δίδεται στην εξασφάλιση των αεροφόρων οδών (Α), της αναπνοής (Β), της κυκλοφορίας (C), τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας (D) και τον έλεγχο για συνοδές κακώσεις (E). Βασικό λοιπόν μέλημα αποτελεί, ο έλεγχος των ζωτικών σημείων του ασθενή (*ΑΠ, HR, RR, SpO₂*), το ΗΚΓ και ο έλεγχος για πιθανή ΚΕΚ (λόγω πτώσης, ξυλοδαρμού, κ.λπ.).
2. Η πρόκληση εμέτου, καθώς και η έκπλυση στομάχου με ρινογαστρικό καθετήρα Levin, έχουν ένδειξη μόνο σε ασθενείς που διατηρούν τις αισθήσεις τους και εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 45-60 λεπτά από την λήψη της αιθανόλης.
3. Εκτελούμε μέτρηση σακχάρου του ασθενούς, με Dextrostick. Πρέπει να θυμόμαστε ότι **η μέθη προκαλεί υπογλυκαιμία** - ιδιαίτερα στους διαβητικούς ασθενείς - διότι μειώνει τη γλυκονεογένεση στο ήπαρ και συνεπακόλουθα μπορεί να παρατείνει επικίνδυνα την υπογλυκαιμική δράση των αντιδιαβητικών φαρμάκων (π.χ. των σουλφονυλουριών).

Εάν η γλυκόζη του ορού είναι $\text{Glu} < 70 \text{ mg/dl}$, χορηγούμε 1000 ml D/W 5%, σε ταχεία ενδοφλέβια έγχυση (εφόσον δεν υπάρχει συνοδός τραυματισμός της κεφαλής - ΚΕΚ). Εφόσον όμως, με τη μέθη, συνυπάρχει και σοβαρή ΚΕΚ, τότε ανατάσσουμε την πιθανή υπογλυκαιμία χορηγώντας 1-3 amp. 10 ml Glucose 35% (iv-bolus) και εν συνεχεία αντιμετωπίζουμε την ΚΕΚ με χορήγηση διαλυμάτων κρυσταλλοειδών N/S ή R/S.

4. Αν υπάρχει υποψία σοβαρού υποσιτισμού ή χρόνιου αλκοολισμού, πρέπει να χορηγηθεί **Θειαμίνη (vit. B₁)** (100-250 mg - iv) 1 amp. MVI (*Evaton / Soluvit*) σε 100 ml N/S, προ της χορήγησης γλυκόζης, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας Wernicke.
5. Τοποθετούμε ουροκαθετήρα Foley 14-16 fr, επειδή η Αιθανόλη αυξάνει τη διούρηση, [μια παρατήρηση που είχε κάνει και ο William Shakespeare στον “Macbeth”!], μέσω του μηχανισμού της ωσμωτικής διούρησης εμποδίζοντας την απελευθέρωση αντιδιουρητικής ορμόνης, γεγονός που οδηγεί σε απρόσφορη διούρηση σε υποογκαιμικούς ασθενείς.
6. Όταν ο οινόφλυγας ασθενής καθίσταται ληθαργικός, βρίσκεται σε κώμα ή ημικωματώδη κατάσταση ή όταν επίσης υποπτευόμαστε και τη συνδυασμένη χρήση Βενζοδιαζεπινών, χορηγείται **Φλουμαζενίλη (Anexate)**, ήτοι: 2 ml = 0,2 mg (iv-bolus) σε έγχυση 15 sec, με επανάληψη της δόσης ανά 60 sec, μέχρι συνολικής δόσεως 1 mg = 10 ml. Σε περίπτωση παρατεταμένης υπνηλίας συνιστάται η χορήγηση 1-2 amp. Anexate στα 1000 ml D₅W ή D₁₀W, με ροή 0,3-0,4 mg/h, μέχρις ότου επανέλθει το επιθυμητό επίπεδο συνείδησης και ο ασθενής μπορεί να διατηρεί την επαφή του με το περιβάλλον. Η Φλουμαζενίλη δεν χορηγείται στη μέθη επί υποψίας ενδοκράνιας υπέρτασης από τραύμα (ΚΕΚ) ή όγκο.
7. Εφόσον υποπτευόμαστε παράλληλη λήψη οπιούχων, χορηγούμε 1-2 amp. Naloxone (iv). Η Ναλοξόνη (amp. *Narcan* 0,4 mg/ml) είναι ανταγωνιστής στους μ, δ, και κ υποδοχείς των οπιοειδών και μπορεί να προλαμβάνει ή/και να αντιστρέφει τις επιδράσεις των οπιοειδών, όπως η αναπνευστική καταστολή, η καταστολή του ΚΝΣ και η υπόταση.
8. Χορηγούνται 1-2 amp. Σιμετιδίνη (*Tagamet 200 mg*) σε 100-250 ml D₅W ή NaCl 0,9% ή/και 1 amp. PPI (*Losec, Nexium*) iv-bolus, αφενός για γαστροπροστασία και αφετέρου για τη μείωση της απορρόφησης του οινοπνεύματος από τον γαστρικό βλεννογόνο.
9. Η Μετοκλοπραμίδη (*Primperan / Veriligo*) αυξάνει την απορρόφηση της αιθανόλης και αποφεύγεται ως αντιεμετικό, παρ’ όλο που θεωρητικά ευοδώνει τη γαστρική κένωση. Αντ’ αυτής μπορεί να δοθεί Ονδασεντρόνη, 1 amp. *Onda* 8 mg / 4 ml, εντός 100 ml N/S.
10. Σκεπάζουμε τον ασθενή με κουβέρτες, για να περιορίσουμε την υποθερμία, που μπορεί να φθάσει και στους 34 °C. Σημειωτέον δε, ότι το αλκοόλ προκαλεί αγγειοδιαστολή και αυξάνει την αποβολή θερμότητας από το σώμα. Λόγω υποθερμίας, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει βραδυκαρδία ($\text{HR} < 50 \text{ bpm}$) που επί αιμοδυναμικής αστάθειας θα χρειαστεί χορήγηση Ατροπίνης, ενώ συνήθως ανατάσσεται με την επαναθέρμανση του ασθενούς.
11. Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του υπό συνεχή και στενή επιτήρηση, από συγγενικό ή φιλικό του πρόσωπο, για τουλάχιστον 12-24 ώρες, (εφόσον δεν φέρει επικίνδυνες συνοδές κακώσεις από πτώση επί του εδάφους ή ξυλοδαρμό ή άλλη συννοσηρότητα ή άλλοτε – και επί κακώσεων – εφόσον ολοκληρώσει τον ακτινοδιαγνωστικό ή άλλον ειδικό έλεγχο).



Αντίδραση Δισουλφιδράμης - Αλκοόλης [Disulfiram - Ethanol Reaction (DER)]:

Η οξεία αντίδραση Αλκοόλης - Δισουλφιδράμης (DER) χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα του προσώπου, αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, θωρακαλγία, δυσκολία στην αναπνοή, υπόταση, δίψα, ναυτία και εμετό. Τα ανωτέρω συμπτώματα στην DER οφείλονται στη συσσώρευση της Ακεταλδεΐδης, λόγω αναστολής του μεταβολισμού της από τη Δισουλφιδράμη.

Όπως είναι γνωστό, η Αιθανόλη στον οργανισμό αρχικώς οξειδώνεται προς Ακεταλδεΐδη, η οποία στη συνέχεια οξειδώνεται προς οξικό οξύ, που τελικά διασπάται προς CO₂ και νερό. Η DER εκδηλώνεται ακόμη και με λήψη ή και μετά από χρήση μικρών ποσοτήτων αλκοόλης, όπως αυτές που περιέχονται σε διάφορα κοινά αλκοολούχα σκευάσματα. Έχουν καταγραφεί περιστατικά DER, ακόμη και με τοπική χρήση αλκοολούχων σκευασμάτων, όπως για παράδειγμα λοσιόν ξυρίσματος!

Τονίζεται ότι μερικά άτομα έχουν πιθανώς προδιάθεση να αναπτύξουν μια αντίδραση παρόμοια με της DER, στις περιπτώσεις συγχορήγησης αλκοόλης και διαφόρων φαρμάκων, όπως Κεφαλοσπορίνες, Μετρονιδαζόλη, Σουλφοναμίδες, Ισονιαζίδη, Αβακαβίρη, Χλωροπροπαμίδη, Βρωμοκρυπτίνη, NTG, κ.ά.